

Eclampsia

1. Introducción y relevancia clínica

La **eclampsia** es la **aparición de convulsiones tónico-clónicas generalizadas** en una mujer **con preeclampsia** (hipertensión + proteinuria o signos de disfunción orgánica), **sin otra causa neurológica identificable**.

Representa la **máxima expresión del espectro de la preeclampsia**, y constituye una **emergencia obstétrica grave** que amenaza la vida materna y fetal.

En Chile, la incidencia actual es de aproximadamente **1 por cada 1.000 embarazos**, pero es responsable de una fracción significativa de **mortalidad materna y perinatal**.

□ En el EUNACOM, las preguntas típicas plantean:

“Gestante de 32 semanas con convulsiones tónico-clónicas, PA 180/110 mmHg y edema generalizado → Diagnóstico: ECLAMPSIA. Primer paso: asegurar vía aérea y administrar sulfato de magnesio.”

2. Fisiopatología y bases conceptuales

La eclampsia forma parte del **síndrome hipertensivo del embarazo (SHE)**. Su base es una **disfunción endotelial generalizada** con vasoespasmo y daño multiorgánico.

Fisiopatología esencial

1. **Anormalidad en la placentación temprana** → hipoxia placentaria.
2. **Liberación de factores antiangiogénicos** (sFlt-1, endoglina soluble).
3. **Daño endotelial sistémico** → aumento de permeabilidad capilar, vasoconstricción y activación plaquetaria.
4. En el cerebro: **vasoespasmo, edema cerebral y microhemorragias**, lo que precipita la convulsión ecláptica.

Factores de riesgo

- Primigesta.

- Antecedente de preeclampsia o eclampsia.
 - Embarazo múltiple.
 - Diabetes, obesidad, hipertensión crónica.
 - Edad <18 o >35 años.
 - Trombofilias o enfermedad renal previa.
-

3. Clasificación

Tipo	Descripción
Eclampsia anteparto	Convulsiones antes del parto (50–60%).
Eclampsia intraparto	Durante el trabajo de parto (20–30%).
Eclampsia posparto	Dentro de las primeras 48 h tras el parto (10–20%).

□ EUNACOM: si una paciente convulsiona hasta 48 h posparto tras un cuadro hipertensivo → sigue siendo eclampsia.

4. Clínica

A. Pródromos o síntomas premonitorios (70%)

- Cefalea occipital intensa.
- Fotopsias, fosfenos o visión borrosa.
- Epigastralgia o dolor en hipocondrio derecho.
- Náuseas, vómitos, hiperreflexia.

B. Crisis ecláptica

- Convulsión tónico-clónica generalizada, de 1–2 minutos.
 - Puede ir precedida por rigidez facial o mirada fija.
 - Posterior a la crisis → período postictal con somnolencia o coma.
 - Puede presentarse hipertensión severa ($\geq 160/110$ mmHg), taquicardia, edema facial, oliguria.
-

5. Diagnóstico diferencial

Cuadro	Elementos diferenciadores
Epilepsia previa	Historia neurológica conocida, sin hipertensión ni proteinuria.
Hemorragia cerebral	Focalización neurológica persistente.
Meningitis / encefalitis	Fiebre, rigidez de nuca.
Hipoglicemia / hiponatremia	Glucemia o electrolitos alterados.

☐ En embarazada hipertensa con convulsión → **asumir eclampsia hasta demostrar lo contrario.**

6. Evaluación inicial y manejo inmediato

Objetivos

1. Prevenir lesión materna.
2. Prevenir hipoxia o aspiración.

- 3. Controlar convulsión.
- 4. Estabilizar presión arterial.
- 5. Evaluar necesidad de interrupción del embarazo.

Paso 1. Manejo de la convulsión

A. Durante la crisis

- Colocar en **decúbito lateral izquierdo**.
- Proteger vía aérea, sin introducir objetos en la boca.
- Aspirar secreciones solo si es necesario.
- Oxígeno a alto flujo (10–15 L/min).

B. Control de convulsiones

- **Sulfato de magnesio (MgSO₄)**: fármaco de elección.

7. Tratamiento farmacológico

A. Sulfato de magnesio (según MINSAL 2023)

Etapa	Dosis	Vía	Detalle
Dosis de carga	4 g EV en 5–10 min + 10 g IM (5 g en cada glúteo)	EV + IM	En solución al 20%
Mantenimiento	1 g EV/h en infusión continua por 24 h post crisis o postparto	EV	Suspender si hay depresión de reflejos o FR <12/min

Control clínico:

- Reflejo patelar presente.
- FR $\geq 12/\text{min}$.
- Diuresis $\geq 25\text{--}30 \text{ mL/h}$.

Antídoto:

- **Gluconato de calcio 10% (10 mL EV lento)** si intoxicación.

☐ El sulfato de magnesio **no controla la hipertensión**, solo previene recurrencia de convulsiones.

B. Control de la hipertensión

Objetivo: mantener PA sistólica 140–160 mmHg, diastólica 90–100 mmHg.

Fármaco	Dosis	Observaciones
Hidralazina EV	5–10 mg cada 20 min hasta control	Fármaco más usado en Chile
Labetalol EV	20 mg inicial → duplicar cada 10 min (máx. 220 mg)	Alternativa segura
Nifedipino VO	10 mg cada 20–30 min (máx. 30 mg)	En contextos leves o sin vía EV

Evitar descensos bruscos → riesgo de hipoperfusión fetal.

8. Conducta obstétrica

Una vez estabilizada la madre:

- La única cura definitiva es el parto.

- No existe indicación de esperar resolución espontánea.

Decisión según edad gestacional y condiciones:

Situación	Conducta
≥34 semanas o feto muerto	Interrumpir de inmediato (preferir parto vaginal si condiciones lo permiten).
<34 semanas, feto vivo y estable	Estabilizar madre, maduración pulmonar con corticoides, interrumpir en 24–48 h según evolución.
Estado fetal comprometido o eclampsia no controlada	Cesárea de urgencia.

Durante el parto, **continuar MgSO₄** y **controlar presión arterial**.

9. Cuidados poscrisis y puerperio

- Mantener **sulfato de magnesio 24 h** después del parto o última crisis.
- Vigilar diuresis, reflejos y signos de toxicidad.
- Control hemodinámico estrecho.
- Evaluar función renal, hepática y coagulación (descartar síndrome HELLP).
- Apoyo emocional y anticoncepción post evento (evitar embarazo precoz <1 año).

10. Complicaciones maternas y fetales

Maternas

- Edema pulmonar.

- Hemorragia intracraneana.
- Coagulación intravascular diseminada (CID).
- Insuficiencia renal aguda.
- Desprendimiento prematuro de placenta (DPPNI).
- Muerte materna.

Fetales

- Sufrimiento fetal agudo.
- Restricción de crecimiento intrauterino.
- Prematurez.
- Muerte perinatal.

□ La causa de muerte más frecuente en eclampsia: **hemorragia cerebral**.

11. Prevención

Primaria

- Control prenatal oportuno.
- Detección y manejo de preeclampsia leve.
- Uso de **aspirina en bajas dosis (100 mg/día)** desde la semana 12–16 hasta 36 en pacientes de alto riesgo.
- Calcio oral (1–1,5 g/día) en mujeres con baja ingesta.

Secundaria

- Diagnóstico y manejo precoz de hipertensión gestacional.
- Educación a gestantes en signos de alarma (cefalea, visión borrosa, dolor epigástrico).

12. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM



Perlas

1. Eclampsia = **preeclampsia + convulsión**.
2. **Sulfato de magnesio** es el tratamiento de elección.
3. **Antídoto del magnesio**: gluconato de calcio 10%.
4. La **cura definitiva**: parto.
5. Controlar la presión con hidralazina o labetalol.
6. Mantener MgSO_4 durante 24 h postparto.
7. Prevenir preeclampsia con aspirina y calcio en mujeres de riesgo.



Errores comunes

- Tratar convulsión con diazepam o fenitoína (no indicados).
- Olvidar gluconato de calcio como antídoto.
- No indicar parto tras estabilización.
- Suspender sulfato de magnesio antes de 24 h.
- Usar metilergometrina en pacientes hipertensas.

13. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. **Eclampsia**: convulsión en paciente con preeclampsia, sin otra causa neurológica.
2. **Tratamiento de elección**: sulfato de magnesio (MgSO_4).

3. **Control de PA:** hidralazina, labetalol o nifedipino.
4. **Antídoto:** gluconato de calcio 10%.
5. **Cura definitiva:** parto una vez estabilizada la madre.
6. **Mantener MgSO_4 por 24 h postparto.**
7. **Prevención:** aspirina + calcio en gestantes de alto riesgo.